



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : ياسمين كامل حسن سويلم

العنوان :

المدينة : طره

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 19-09-2026

رقم البطاقة : 28401050103285 رقم التليفون : 01140032023

العمر(تاريخ الميلاد) : 05-01-1984 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مسح ذري علي العظام [12966] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني

الاسم : د/ندى حسن

الاسم : د/نرمين رمضان

الوظيفة :

الوظيفة :

الوظيفة :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة

رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /..... /د. /..... /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

قسم :

جهة العلاج :

نفقات :

ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ياسمين كامل حسن سويلم National ID: 28401050103285	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Bone scintigraphy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٢٠٢٢/١٠

٢٨٤٠١٠٥٠١٠٣٢٨٥
خاتمة شى معبد شى تجارى



مترجمة
مصلحة
امنى
تامر محمد السيد محمد الجورى
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٢/١٠/٢٢



دولة فلسطين
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

ياسين
كامل حسن مويطم
٢٢ ش حسن صيدان الرقش - مزرعة النبط
دار السلام - القاهرة



٢٨٤٠١٠٥٠١٠٣٢٨٥

JP7404913

Name	ياسمين كاسم كاسم	MRN	1162/2025
Age	41	ID	83271531
Menopausal status	premenopausal	Phone	01140032023
NRS SCORE		Marital status	CAE. 1.0.1.2CAO
BMI		Family history	premeno pausal
CO morbidity		REASON OF MDT	plan of management

Clinical Data

BX:

ER:

718

PR:

618

HER 2:

(+3)

Ki67:

Sonomammography:

Mets Workup:

11/12/2025

CTCAP → Metastatic breast Cancer
to liver & bones. Hf 1.8 x 2.3 cm
l.t. breast mass 4.7 x 4 cm
axillary 1.1 x 0.9 x 1.6 cm

Recommendations: bil pulm. nodules larger 4 x 8 mm.
received 8 cycles Taxotere 6 cycles Herceptin.

last 11/12/2025

CTCAP 21/10/2025

⇒ R.D. Hf 8 x 6 mm

13 breast → CR

pulm-nodule, RD 4mm

For next plan of management.

MDT OUTCOME & PLAN

Sub 11/12/2025.

To Stop taxotere & keep on
herceptin only + ET Tamoxifen?
+ Tamoxifen 13mm

SIGNATURE & Date					
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

Patient Name : الأستاذ / ياسين كامل حسن سويلم
Patient No. : 28401050103285
Path No. : SR-623/25
Sex : Female
Age : 41 Y
Referring Doc :

Request No. : 13009709
Request Date : 26/04/2025
Verification Date : 05/05/2025
Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data
Left breast mass

Nature of specimen
Block & slide revision

Gross examination

One block labelled by (944732) & 4 slides were received

IHC technique: Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench

Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination

- * Histological type: Invasive duct carcinoma
- * Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): (3+2+2) Grade II
- * DCIS: Positive
- * Angioinvasion: Couldn't be detected in the received biopsy
- * Perineural invasion: No
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity) :
- * ER: Strong nuclear reaction in 50 % tumor cells (Allred score 7/8)
- * PR: Moderate nuclear reaction in 40 % tumor cells (Allred score 6/8)
- * HER2: Strong complete membrane reaction in >10 % of tumor cells (score 3+)

Diagnosis

Left breast mass, block revision:

Verified by :
Dr. Heba Hasan

Printing Date : 07/05/2025 09:26:35

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name	: الأستاذ / ياسمين كامل حسن سويلم	Request No.	: 13009709
Patient No.	: 28401050103285	Request Date	: 26/04/2025
Path No.	: SR-623/25	Verification Date	: 05/05/2025
Sex	: Female	Financial Category	: أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 41 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Invasive duct carcinoma, Grade II DCIS

IPT:

- * ER: Positive (score 7/8).
- * PR: Positive(score 6/8).
- * HER2:Positive (score 3+).

Signature
Prof. Dr. Gamal Abdelatty
Dr.Menan Hosam

Verified by :
Dr.Heba Hasan

Printing Date : 07/05/2025 09:26:35

Page 2 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss



شرفة رقم (4) - الدور الاول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name: Yasmin Kamel Hassan	Date : 21/10/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 41 Year(s)
Medical ID: 1162/2025	Pat. ID: 99369

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Reported case of breast cancer. Compared to the previous study dated 7/5/2025, the current study showed:

I Chest:-

- The previously seen left breast and left axillary lymph nodes are no longer seen in today's study.
- Regressive course regarding the size and number of the previously seen few bilateral scattered pulmonary nodules, largest seen at the right upper lobe measuring about 4 mm in today's study.
- No hilar or mediastinal pathologically enlarged lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- Mildly enlarged liver with homogenous CT texture. Regressive course since last study regarding the previously seen few right hepatic lobe hypodense focal lesions with the largest being subcapsular at segment VI measures about 8.8 x 6.8 mm in today's study.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Bulky uterus and both ovaries are also noted for us correlation if clinically warranted.
- Unremarkable appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

*Scanned skeleton:

- Sclerosis of the previously seen axial and appendicular skeleton lytic bone lesions.
- Anterior wedging of D7 vertebral body.
- Healed left inferior pubic ramus fracture.

Opinion:

- Regressive course since last study as described.

Dr. Sherif Wagdy

Signature Dr. Mohamed Hassan
24/10/2025 5:20 PM

Name : YASMIN KAMEL HASAN SEWELAM
Branch : Maadi
Ref.Physician Prof : 1 doctor

Date : 07-05-2025 05:08
Medical No. : 110873399
Ins.Company :

Tc^{99m} MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History:

- A 41-year-old lady, with history of left breast cancer, referred for metastatic work up.

Technique:

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of the tracer.

Findings:

- Enhanced tracer uptake is noted at back of the skull bones, right shoulder and right proximal humeral shaft, sternum, bilateral ribs, mid and lower dorsal spine, right femoral head, left acetabulum, left pubic bone as well as trochanteric region of left femur.
- Degenerative changes are seen at the spine and big joints.

Impression:

- Numerous metastatic osseous lesions at the aforementioned sites, for follow up.

*Much obliged
Dr. Alaa Nagi, MD
Consultant of nuclear medicine*

15/05/2025

To whom it may concern

Miss / Mr

John L. 42 years old

female/male patient presented with diagnosis

HBc to home

She/ He was referred to us for (radical / adjuvant / Neoadjuvant / palliative) Radiotherapy

She/He has received (3D/IMRT) radiotherapy to

Pt. Shoulder + der. scap. vertebrae

4. Dose: 20 Gy/5 W/1 W.

Additional (Boost) : yes/ no. at doseGy/.....Kv/.....w
(sequential / concomitant)

Started: 3/9/2026

Ended: 17/9/2026 With good tolerance.

Head of department

Dr. Henry William

Dr. Chang William
Wang, De
can 1911